

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

PANSS · ESCALA DE LOS SÍNDROMES POSITIVO Y NEGATIVO

Positive and Negative Syndrome Scale – Patrón de referencia internacional para la evaluación tipológica y dimensional de la esquizofrenia

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Positive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia (PANSS)
Autores Originales	Stanley R. Kay, Abraham Fiszbein y Lewis A. Opler (1987)
Validación Española	Víctor Peralta Martín y Manuel J. Cuesta (1994); Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica estructurada heteroaplicada e informe observacional de informantes
Población Diana	Pacientes adultos y adolescentes diagnosticados de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos
Tiempo de Aplicación	40 a 50 minutos (30 a 40 min entrevista semiestructurada SCI-PANSS + 10 min calificación)
Formato de Respuesta	Escala Likert clínica de 7 puntos: 1 (Ausente) a 7 (Extremo / máxima gravedad)
Finalidad Clínica	Perfilado psicopatológico dimensional (positivo, negativo y general), clasificación tipológica de la esquizofrenia y medición estandarizada de eficacia en ensayos antipsicóticos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Heredera del modelo dicotómico de Timothy Crow sobre la esquizofrenia Tipo I (positiva, reversible, ligada a hiperactividad dopaminérgica D2 subcortical) y Tipo II (negativa, deficitaria, asociada a pérdida neuronal prefrontal y pobre respuesta terapéutica), la PANSS integró reactivos de la BPRS y de la Psychopathology Rating Schedule para resolver las deficiencias de medición de los síntomas deficitarios.

Kay, Fiszbein y Opler concibieron la PANSS no como una mera suma de síntomas, sino como un sistema tridimensional exhaustivo: a) **Escala Positiva (PANSS-P)**, que mide excesos o distorsiones morbosas de las funciones normales (delirios, alucinaciones, desorganización conceptual); b) **Escala Negativa (PANSS-N)**, que cuantifica la disminución o pérdida de funciones cognitivas y emocionales adaptativas (embotamiento afectivo, retraimiento social y pasivo, pobreza del lenguaje); y c) **Escala de Psicopatología General (PANSS-G)**, que evalúa el fondo ansioso, depresivo, somático, descontrol motor y falta de insight sobre la propia enfermedad.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala PANSS	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Dimensiones Evaluadas
Escala Positiva (P)	7 ítems	P1 Delirios, P2 Desorganización conceptual, P3 Conducta alucinatoria, P4 Excitación, P5 Grandiosidad, P6 Susplicacia/persecución, P7 Hostilidad. (Rango: 7-49).
Escala Negativa (N)	7 ítems	N1 Embotamiento afectivo, N2 Retraimiento emocional, N3 Pobre relación, N4 Retraimiento social pasivo, N5 Dificultad de pensamiento abstracto, N6 Falta de fluidez, N7 Pensamiento estereotipado. (Rango: 7-49).
Psicopatología General (G)	16 ítems	G1 Preocupaciones somáticas, G2 Ansiedad, G3 Culpa, G4 Tensión motora, G5 Manierismos, G6 Depresión, G7 Retardo motor, G8 Descooperación, G9 Pensamientos inusuales, G10 Desorientación, G11 Atención, G12 Insight, G13 Trastornos volitivos, G14 Control de impulsos, G15 Preocupación, G16 Evitación activa. (Rango: 16-112).
Puntuación Total PANSS	30 ítems	Suma global P + N + G (Rango absoluto: 30 a 210 puntos).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · PANSS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach excelente en España (Peralta & Cuesta, 1994): Escala Positiva = 0.73 a 0.83; Escala Negativa = 0.83 a 0.92; Psicopatología General = 0.80 a 0.87; PANSS Total = 0.89 a 0.93.
Fiabilidad Inter-Jueces	Coefficiente de correlación intraclase ICC = 0.82 a 0.94 entre psiquiatras tras entrenamiento formal con cintas de vídeo calibradas.
Estructura Factorial	Modelos pentafactoriales (White et al., Wallwork et al.) confirman 5 dimensiones clínicas: Positiva, Negativa, Desorganizada/Cognitiva, Excitación y Afectiva/Depresión.
Sensibilidad y Estándar	Criterio regulador universal obligatorio (FDA/EMA/AEMPS) para determinar respuesta en ensayos clínicos antipsicóticos (exigencia de reducción $\geq$ 20% a 30% en PANSS Total).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Calificación de Cada Ítem (1 a 7):**
 - 1 = Ausente; 2 = Mínimo; 3 = Leve; 4 = Moderado; 5 = Moderadamente grave; 6 = Grave; 7 = Extremo.
- Cálculo de Subescalas:**
 - Subtotal Positivo (P):** Suma de P1 a P7 (Rango: 7 a 49).
 - Subtotal Negativo (N):** Suma de N1 a N7 (Rango: 7 a 49).
 - Subtotal Psicopatología General (G):** Suma de G1 a G16 (Rango: 16 a 112).
- Puntuación Total PANSS:** Suma de los 30 ítems (Rango: 30 a 210).
- Fórmula de Puntuación Compuesta (Índice Positivo/Negativo):** Puntuación Compuesta = P - N (Rango: -42 a +42; valores positivos indican predominio de síntomas positivos; negativos indican predominio deficitario).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

PANSS Total	Estratificación	Equivalente CGI	Estado Clínico y Asistencial
≤ 45 puntos	Remisión Sintomática	1 a 2 (Normal / Leve)	Criterios de remisión de Andreasen et al. Mantenimiento.
46 a 58 puntos	Psicosis Leve	3 (Levemente enfermo)	Ambulatorio estable; rehabilitación psicosocial activa.
59 a 75 puntos	Psicosis Moderada	4 (Moderadamente enfermo)	Compromiso funcional evidente; optimizar antipsicóticos.
76 a 95 puntos	Psicosis Grave	5 (Marcadamente enfermo)	Agudización sintomática; considerar ingreso hospitalario.
≥ 96 puntos	Psicosis Muy Grave	6 a 7 (Gravemente enfermo)	Descompensación severa con riesgo vital; ingreso urgente.

CRITERIOS DE REMISIÓN CLÍNICA (ANDREASEN ET AL., 2005): Para declarar a un paciente en "Remisión Sintomática" se exige que una constelación de 8 ítems nucleares (P1 Delirios, P2 Desorganización, P3 Alucinaciones, N1 Embotamiento, N4 Retraimiento pasivo, N6 Pobre fluidez, G5 Manierismos y G9 Pensamientos inusuales) obtengan una puntuación individual ≤ 3 ("Leve o ausente") mantenida durante un mínimo de 6 meses.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · PANSS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Administración de la Entrevista Semi-Estructurada (SCI-PANSS): Evaluar síntomas referidos a la última semana.

Paso 2: Formulación Terapéutica por Subescala Predominante:

- **Predominio Positivo (P > N):** Optimizar antipsicóticos con fuerte bloqueo D2 o atípicos de segunda generación (Risperidona, Olanzapina, Paliperidona LAI).
- **Predominio Negativo / Deficitario (N > P):** Evitar antipsicóticos típicos sedantes que induzcan parkinsonismo secundario; indicar cariprazina o aripiprazol por su acción agonista parcial D3/D2 y vincular a programas de remediación cognitiva y terapia ocupacional.
- **Falta de Respuesta (< 20% reducción en PANSS Total tras 2 antipsicóticos a dosis plenas):** Esquizofrenia resistente; indicación formal de Clozapina.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 28 años diagnosticada de Esquizofrenia Paranoide, trasladada a la Unidad de Agudos de Psiquiatría por escolta policial tras atrincherarse en su domicilio colocando planchas de metal en las ventanas para bloquear "las radiaciones microondas de los vecinos".

Evaluación Psicométrica Inicial en PANSS: Total = 104 / 210 puntos (Psicosis Muy Grave).

- **Escala Positiva (P):** 32 / 49 puntos. Delirios persecutorios irreductibles y de control externo (P1 = 6), alucinaciones auditivas comentadoras peyorativas continuas (P3 = 6), suspicacia extrema (P6 = 6) y desorganización formal del pensamiento (P2 = 5).
- **Escala Negativa (N):** 19 / 49 puntos. Aislamiento pasivo prolongado (N4 = 5) y embotamiento afectivo moderado (N1 = 4).
- **Psicopatología General (G):** 53 / 112 puntos. Ansiedad psíquica severa (G2 = 5), falta absoluta de conciencia de enfermedad mórbida (G12 = 6) y desconfianza hostil (G8 = 5).

Manejo Hospitalario y Evolución: Dada la mala adherencia ambulatoria previa, se instauró tratamiento con palmitato de paliperidona inyectable de liberación prolongada mensual (iniciando pauta de carga). A las 6 semanas de seguimiento ambulatorio, la PANSS Total se redujo a 51 puntos (reducción del 51.0%, cumpliendo criterios de respuesta terapéutica sobresaliente), desapareciendo el fenómeno alucinatorio y recuperando la convivencia pacífica en su entorno familiar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE RIESGO

- Alucinaciones imperativas de suicidio o agresión (P3 >= 5) asociadas a descontrol de impulsos (G14 >= 5) exigen vigilancia estricta individualizada.
- Descartar Síndrome Neuroléptico Maligno ante rigidez súbita extrema (G4 = 7) y fiebre no filiada.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Depresión Post-Psicótica:** Evaluar ítem G6 frente a los síntomas deficitarios de la escala negativa (N1 a N4).
- **Sintomatología Negativa Secundaria:** Distinguir entre abulia primaria y sedación/parkinsonismo inducido por antipsicóticos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Kay, S. R., Fiszbein, A., & Opler, L. A. (1987). The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 13(2), 261–276.
- Peralta, V., & Cuesta, M. J. (1994). Validación de la escala de los síndromes positivo y negativo (PANSS) en una muestra de esquizofrénicos españoles. *Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines*, 22(4), 171–177.
- Andreasen, N. C., Carpenter, W. T., Kane, J. M., Lasser, R. A., Marder, S. R., & Weinberger, D. R. (2005). Remission in schizophrenia: Proposed consensus criteria for clinical practice and research. *American Journal of Psychiatry*, 162(3), 441–449.
- Leucht, S., Kane, J. M., Kissling, W., Dold, M., & Engel, R. R. (2005). Clinical implications of Brief Psychiatric Rating Scale scores. *British Journal of Psychiatry*, 187(4), 366–371.